GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

PATIENT EDUCATION · GASTROENTEROLOGY

과민성 장 증후군 (IBS), 뇌-장 축의 올바른 이해

Rome IV 진단부터 저포드맵 식단, 아형별 표적 약물 치료까지 — 삶의 질을 회복하는 단계적 관리

IBS · Rome IV · Low-FODMAP · Targeted Pharmacotherapy

광교바른내과 소화기내과

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 결론 — 과민성 장 증후군, 이것만 기억하세요

흔하고, 암이 되지 않으며, 단계적으로 관리하면 좋아집니다

1

흔한 병입니다

어른 100명 중 **4~11명**이 겪습니다. 여성과 젊은 층에 더 많습니다.

혼자만의 문제가 아닙니다

2

장과 뇌의 연결이 예민해진 상태

내시경·피검사는 정상인데 배가 아프고 배변이 달라집니다. 장이 망가진 것이 아니라 **장과 뇌 사이 신호**가 예민해진 것입니다.

암·염증성 장질환으로 가지 않습니다

3

단계적으로 관리합니다

생활습관 → 식단 조절 → 증상에 맞는 약 순서로 접근하면 대부분 좋아집니다.

경고 증상은 먼저 확인

Tip · 예민한 성격 탓이 아닙니다. 신경의 감각이 달라진 것이라 자책할 필요가 없습니다.

근거 · Rome IV · ACG 진료지침 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 때 과민성 장 증후군으로 진단합니다

로마 기준(Rome IV) — 증상의 기간·빈도·배변과의 관계를 봅니다

최근 3개월 동안

증상이 최근 3개월 동안 이어졌고, 처음 시작은 6개월 이상 전입니다.

일주일에 한 번 이상 복통

배가 아픈 날이 평균 주 1회 이상 되풀이됩니다.

배변과 관련된 통증

배변과 함께 아프거나 나아지고, 횟수나 변 모양이 달라집니다.

장 신경이 예민해진 상태

보통의 장 움직임이나 가스도 뇌가 심한 통증으로 느낍니다(내장 과민성).

Tip · 증상이 언제·얼마나 자주 생기는지 기록해 오시면 진단이 훨씬 정확해집니다.

근거 · Rome IV 진단 기준(2016)

Rome IV 다음의 Rome V 기준

앞 장은 2016년 Rome IV이며, 이 장에서는 2026년 Rome V의 변화를 비교합니다

빈도·증상 범위 변화

최근 3개월 평균 **월 3일 이상**의 반복되는 복통 **또는 복부 불편감**을 봅니다. Rome IV의 주 1일 이상 복통 기준보다 범위가 넓어졌습니다.

관련 조건과 구분할 증상

최소 6개월 전 시작했고, **배변·배변 횟수·변 형태 변화 중 2가지 이상**과 관련됩니다. 지속적·거의 지속적인 통증이나 월경기간에만 있는 증상은 구분해 평가합니다.

통증·불편감의 빈도와 배변 관련성을 함께 기록합니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

변 모양으로 나누는 네 가지 유형

유형에 따라 쓰는 약이 달라집니다 — 2주 동안 변 모양을 적어 오세요

변비형

딱딱한 변이 많고 배변 뒤에도 덜 본 느낌이 남습니다.
배가 더부룩합니다.

설사형

묽은 변이 많고 갑자기 급하게 화장실을 찾게 됩니다.

혼합형 · 미분류형

설사와 변비가 번갈아 오거나(혼합형), 어느 쪽도 뚜렷하지 않고 복통·가스가 주된 경우(미분류형)입니다.

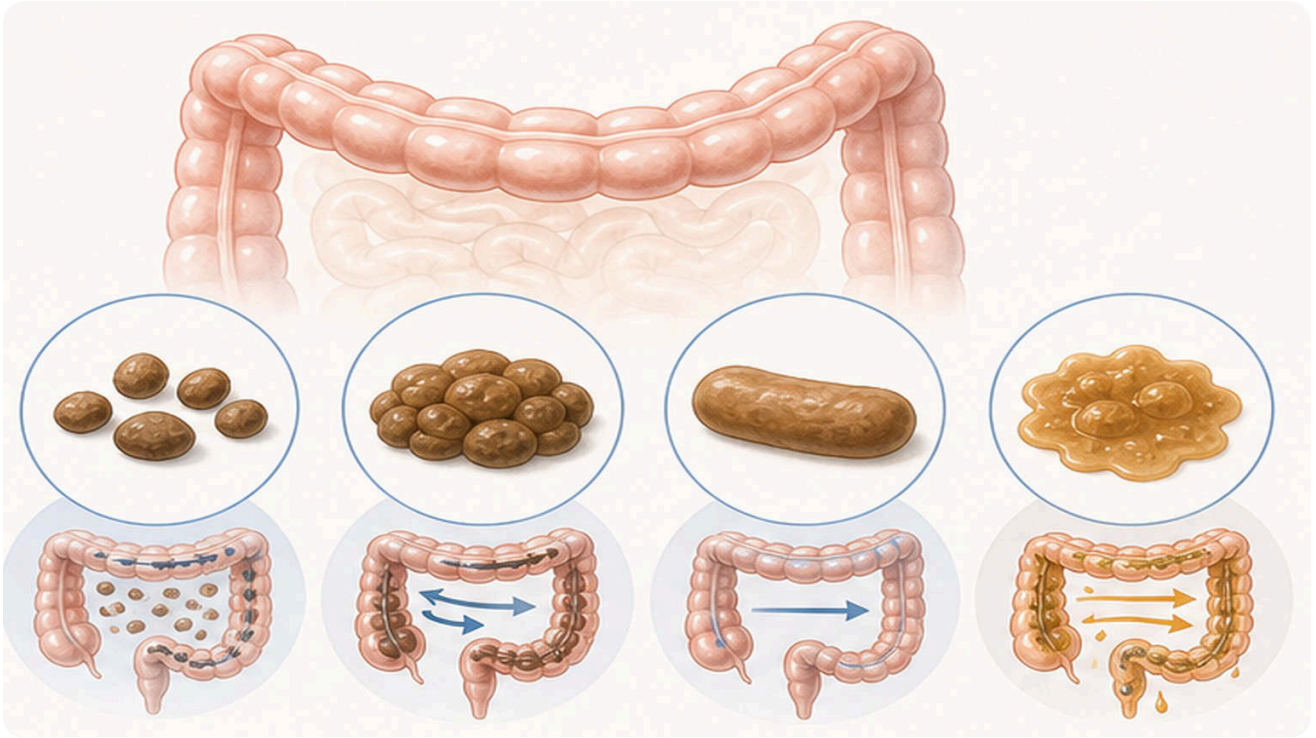


그림 · 변의 모양(딱딱함 ↔ 묽음)이 유형을 나누는 기준입니다(설명용 그림).

근거 · Rome IV 유형 분류 · 브리스톨 대변 척도

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

변 모양과 배변 기능을 함께 봅니다

증상과 필요한 검사로 진단하고, 모든 검사를 일률적으로 하지는 않습니다

딱딱함·묽음의 기준

브리스톨 변형태도 **1–2형은 딱딱한 변, 6–7형은 묽은 변**입니다. 변비형·설사형·혼합형으로 나누고, 기능성 변비·설사와 증상이 겹칠 수도 있습니다.

배변이 막히는 느낌

과도한 힘주기·배변곤란·잔변감·손가락 관장 필요를 확인합니다. 진찰에서 배변장애가 의심되면 **항문직장내압·풍선배출검사**로 바이오피드백 치료 대상을 살핍니다.

검사는 증상·진찰 소견과 연결해 선택합니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

증상을 부르는 두 가지 방아쇠

병의 원인이 아니라 이미 예민한 장을 자극하는 계기입니다

스트레스

긴장하면 장과 뇌 사이 신호가 더 예민해집니다.

- 스트레스 호르몬이 장벽을 느슨하게 만듭니다
- 보통의 자극도 더 아프게 느껴집니다
- 규칙적 운동 · 충분한 잠 · 느린 호흡이 도움이 됩니다

vs

포드맵(FODMAP) 음식

소장에서 잘 흡수되지 않는 탄수화물입니다.

- 장으로 물을 끌어들여 설사를 부릅니다
- 대장 세균이 발효시켜 가스를 많이 만듭니다
- 밀·양파·마늘·우유·일부 과일에 많습니다(자세한 목록은 식사 안내문)

Tip · 두 가지 모두 '없애야 할 원인'이 아니라 '줄여 볼 계기'입니다.

근거 · Monash University 포드맵 · Mayer 2011

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

우유·음료가 모두에게 같은 문제는 아닙니다

잘 흡수되지 않는 탄수화물은 물과 가스를 늘릴 수 있습니다

흡수장애와 불내증

유당을 소화·흡수하지 못하는 **유당 흡수장애**와, 먹은 뒤 복통·팽만·설사가 생기는 **유당불내증**을 구분합니다. 나이가 들며 유당분해효소가 줄 수 있습니다.

과당·액상과당의 양

소장의 흡수능을 넘으면 대장 발효·삼투 작용으로 가스와 수분이 늘 수 있습니다. 탄산·과일·스포츠음료, 시럽·소스도 살피되 **개인의 증상 반응**으로 판단합니다.

유당·과당·프룩탄·갈락탄·폴리올 등과 증상 관계를 봅니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

장 증상과 수면·기분·다른 통증을 함께 봅니다

통증에 예민해지는 중추감작과 동반 문제를 함께 살핍니다

신경계 민감화와 동반 증상

중추감작은 **만성통증·수면장애·기분장애·턱관절통·IBS**와 함께 나타날 수 있습니다. 다른 부위 통증과 장 증상이 겹치는지 알려주세요.

잠·기분도 치료에 연결

수면·우울 증상도 적극적으로 치료하고 필요하면 다른 진료과와 함께 진료합니다. 장-뇌 상호작용을 함께 살피되 **장 증상을 기분 문제로만 단정하지 않습니다.**

복통·배변과 함께 잠·기분·다른 부위 통증의 변화도 기록합니다.

아산 28회 연수강좌 — 허리 통증의 진단과 치료(조재환)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

저포드맵 식단은 3단계로 짧게 해 봅니다

평생 참는 식단이 아니라 '나에게 맞지 않는 음식'을 찾는 과정입니다

1단계

빼 보기(elimination)

포드맵이 많은 음식을 빼고 식사 안내문의 대체 음식으로 식단을 짭니다. 오래 빼면 장 속 좋은 균이 줄어듭니다.

짧게 시험

2단계

다시 먹기 (reintroduction)

음식 종류를 하나씩 조금씩 다시 먹으며 무엇이 문제인지 찾습니다.

범인 찾기

3단계

나에게 맞추기

괜찮은 음식은 자유롭게, 문제 음식만 견딜 만큼 줄입니다.

다양하게 먹기

해 봐도 그대로면

다른 방법으로

식단이 원인이 아닐 수 있어 약물 또는 의사 상의가 필요합니다. 장-뇌 심리치료도 방법입니다.

진료에서 상의

Tip · 의사 확진 후 시작하고, 설사형은 수분 섭취를 유지하세요. 단계별 기간과 음식 목록은 식사 안내문을 따릅니다.

근거 · Monash University 저포드맵 3단계

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

저포드맵은 4~6주 평가 뒤 다시 먹어 봅니다

엄격한 제한식을 오래 유지하는 치료가 아닙니다

효과가 있으면 재도입

보통 **4~6주** 시행해 효과를 평가합니다. 반응하면 식품을 단계적으로 다시 넣어 개인별 유발 음식과 허용 범위를 찾고, 효과가 없으면 계속 제한하지 않습니다.

한국 식사·수분도 함께

김치가 서구 분류상 고FODMAP이어도 한국인 연구에서는 증상과의 상관성이 높지 않았습니다. 당이 많은 이온·과당·탄산음료는 과량 섭취 시 증상을 악화시킬 수 있습니다.

심한 설사·탈수는 이온음료만으로 보충하지 않고 평가받습니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약은 유형과 증상에 맞춰 고릅니다

약 이름보다 '어떤 증상을 겨냥하는가'가 중요합니다

변비형

변을 부드럽게 하고 복통을 함께 줄이는 쪽

장 분비를 늘리는 약

리나클로타이드 등 — 변비와 복통을 함께 덜어 줍니다. 설사가 부작용으로 올 수 있습니다.

장 경련을 푸는 약

배가 쥐어짜듯 아플 때 씁니다.

통증 신호를 누그러뜨리는 약

저용량 아미트립틸린 등 — 입 마름·변비 같은 부작용을 살핍니다.

설사형

장 속 환경을 바로잡고 설사를 줄이는 쪽

장 속 세균 환경을 바꾸는 약

리팍시민 — 몸에 거의 흡수되지 않는 항생제로 2주 먹고, 다시 나빠지면 한 번 더 쓸 수 있습니다.

설사를 멎게 하는 약

로페라마이드 — 변을 굳히지만 배 아픔은 줄이지 못합니다.

장 경련 · 통증 약

복통이 심할 때 함께 씁니다.

Tip · 나라마다 쓸 수 있는 약과 보험 적용이 다릅니다. 실제 처방은 진료에서 함께 정합니다.

근거 · ACG 진료지침 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

설사 위주인지, 복통도 함께인지로 약을 고릅니다

로페라마이드·라모세트론은 처음부터 함께 쓰는 것이 일반 전략은 아닙니다

설사가 주증상이면

로페라마이드는 **횟수·변 형태**를 조절하지만 복통·전반적 증상 효과는 작습니다. 저용량부터 조절하며 변비·팽만·오심과 과량 복용을 주의합니다.

복통·설사가 함께라면

라모세트론은 복통·묽은 변·급박변을 함께 줄이는 선택지입니다. **2~4주 후** 효과와 변비를 평가합니다. 한 약으로 불충분할 때만 병용을 신중히 고려합니다.

52주 안전성 자료와 수년간 지속 복용 근거는 구분하며 재평가합니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

가스·팽만이 두드러지면 리팍시민을 고려합니다

모든 설사형 IBS에 일률적으로 쓰는 약은 아닙니다

어떤 증상에 쓰나요

가스·복부팽만이 두드러지거나 장내미생물 이상이 의심되는 IBS-D에서 선택합니다. 반응 뒤 재발하면 **재치료**를 고려할 수 있습니다.

용량·기간은 의료진이 결정

항생제 치료는 **증상과 상태에 따라 의료진이 용량과 기간을 정합니다.** 증상이 다시 생겨도 남은 약을 임의로 복용하지 않고 진료에서 재치료 여부를 확인합니다.

항생제의 용량과 복용 기간은 개인별 처방을 따릅니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

변이 잘 나오는 효과와 복통 효과는 다릅니다

변비형에서는 배변과 통증을 각각 평가합니다

PEG와 락툴로오스

PEG는 장내 세균 대사가 없어 락툴로오스보다 가스가 적습니다. 연구에서 배변 횟수는 늘었지만 **복통·불편감은 위약과 유의한 차이가 없었습니다.** 락툴로오스는 가스·팽만을 살핍니다.

기존 치료 반응이 부족하면

IBS-C에서 일반 변비 치료가 불충분하면 프루칼로프라이드 등을 고려할 수 있습니다. **IBS-D에서 위장운동촉진제의 역할은 제한적**입니다.

당뇨가 있으면 락툴로오스의 복용량·제품 당류·혈당도 함께 봅니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

유산균은 균주별로 보는 보조 치료입니다

제품 이름이나 유산균이라는 분류만으로 같은 효과를 기대하지 않습니다

일부 환자에서 선택

팽만이 두드러지거나 약물치료를 원하지 않을 때, 다른 치료의 **보조**로 고려할 수 있습니다. 프리바이오틱스는 균의 먹이, 신바이오틱스는 두 가지 조합입니다.

효과의 한계

82개 무작위시험·10,332명에서 일부 균주의 효과가 보고됐지만 **근거 수준은 대체로 낮거나 매우 낮았습니다.** 균주·함량이 다르고, 무증상 건강인에게 장기 복용을 반드시 권할 근거는 부족합니다.

특정 균주를 모든 환자에게 일률적으로 권할 근거는 부족합니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

경련성 복통과 오래가는 통증을 나누어 봅니다

진경제와 신경조절제는 겨냥하는 증상과 주의점이 다릅니다

간헐적 쥐어짜는 복통

진경제는 식후 악화되는 경련성 복통에서 고려합니다. 변비형·설사형·혼합형에 사용할 수 있지만 **입마름·변비·시야흐림·요폐** 등 부작용을 함께 봅니다.

저용량 신경조절제

아미트립틸린은 낮은 용량으로 시작하며, **용량과 조정 간격은 의료진이 정합니다.** 장-뇌 축 통증 조절이 목적이며, 고령자는 더 낮게 시작하고 IBS-C의 변비·졸림·운전·고소작업을 살핍니다.

효과가 있으면 수개월 유지 후 서서히 감량하며 벤조디아제핀은 표준 치료가 아닙니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

ADHD 약을 먹는다면 장 증상 처방 전에 알립니다

소아 ADHD 치료 중 다른 약을 함께 쓸 때 확인할 사항입니다

TCA·부프로피온 병용

에나폰(아미트립틸린) 같은 TCA와 웰부트린(부프로피온)은 교감신경계 작용 때문에 ADHD 약과 병용을 신중히 판단합니다.

다른 약도 개별 확인

ADHD 약과 SSRI는 함께 사용할 수 있는 경우가 많습니다. **소아에서의 병용도 개별 판단이 필요**하므로 약 이름·용량을 보여 주고 상호작용을 확인합니다.

장 통증 약을 처방받기 전에 ADHD 약을 포함한 전체 약 목록을 보여 주세요.

아산 28회 연수강좌 — 소아 ADHD 진단과 치료의 최신 지견(김효원)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

약을 더하기 전에 주증상과 진단을 다시 봅니다

모든 약을 평생 계속할 필요는 없습니다

반응이 부족할 때

여러 신경조절제를 동시에 더하기보다 **가장 문제가 되는 증상**에 맞춰 한 약을 조절합니다. 기능성 소화불량·변비가 겹치면 변비 교정만으로 상부 증상도 나아질 수 있습니다.

좋아진 뒤에도 재평가

효과가 분명하면 유지할 수 있지만, 안정되면 **최소 유효용량·감량·중단**을 검토합니다. TCA는 수개월 유지 후 서서히 줄이고 재발하면 이전 효과 용량과 지속 필요성을 다시 평가합니다.

미르타자핀·에스시탈로프람·둘록세틴을 장 증상만으로 일상적으로 추가하지 않습니다.

대변 칼프로텍틴 — 장에 염증이 있는지 보는 검사

염증성 장질환과 구별할 때 씁니다 (단위 μg/g)

결과	뜻과 다음 단계
50 이하	염증성 장질환일 가능성이 낮습니다. 경고 증상이 없으면 과민성 장 증후군 쪽으로 판단하는 데 도움이 됩니다.
51~120	경계입니다. 소염진통제나 잠깐의 장염 때문일 수 있어 4~6주 뒤 다시 잽니다.
121~250	염증 가능성이 올라갑니다. 증상과 함께 보고 담당 의사가 대장내시경 등 추가 검사를 정합니다.
250 초과	장 염증 가능성이 높습니다. 감염·복용 약·증상을 함께 확인하고, 담당 의사가 재검·전문의 진료·내시경 필요성을 정합니다.

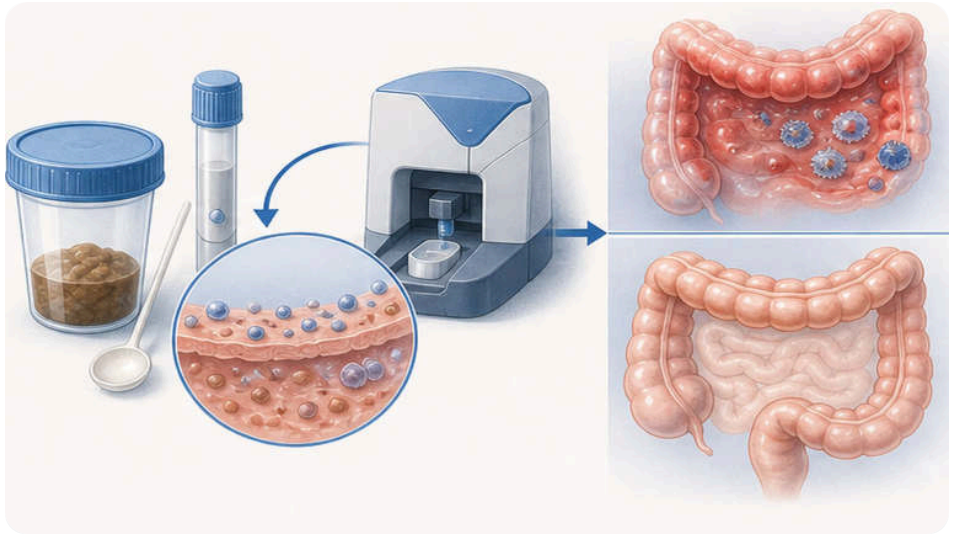


그림 · 대변 속 염증 물질을 재서 장 염증 여부를 가늠합니다(설명용 그림).

근거 · van Rheenen 2010 · 칼프로텍틴 감별 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈액·대변검사는 목적과 위험에 맞춰 선택합니다

Rome V와 국내 지침에 따른 검사의 역할을 구분합니다

기본 검사·선택 검사

Rome V 기본 검사에는 **CBC·CRP·셀리악 혈청검사**가 포함되지만 국내 셀리악병은 드뭅니다. TSH·혈액화학·칼프로텍틴·지아르디아·장관병원체 검사는 증상과 위험에 따라 선택합니다.

모든 검사가 필요한 것은 아닙니다

국내 지침에서는 **경고 증상이 있으면 ESR 등 염증 표지자 검사를 고려**합니다. 장관병원체·분변잠혈검사를 모두에게 일률 시행하지 않으며, Rome V는 ESR도 일상 검사로 권하지 않습니다.

검사 결과 하나보다 증상·경고신호·진찰을 함께 판단합니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 증상이 있으면 먼저 검사가 필요합니다

하나라도 있으면 과민성 장 증후군으로 보기 전에 대장암·염증성 장질환을 확인합니다

1

피가 섞이거나 검은 변 · 빈혈

설명되지 않는 출혈 신호는 대장암·염증성 장질환·궤양의 신호일 수 있습니다.

대장내시경

2

모르게 빠지는 체중

다이어트 없이 6개월 안에 몸무게가 5% 넘게 줄었다면 원인을 찾아야 합니다.

원인 검사

3

가족력 · 50세 이후 새 증상

대장암·염증성 장질환·셀리악병의 직계 가족력, 50세 넘어 새로 생긴 증상, 밤에 배가 아프거나 설사로 깨는 경우입니다.

추가 검사

Tip · 과민성 장 증후군은 대개 밤에 잠을 깨울 만큼 아프지 않습니다.

근거 · ACG 경고 증상 · 대한소화기기능성질환·운동학회

치료해도 지속·악화되면 다시 검사합니다

처음 진단 뒤에도 새 경고신호와 치료 반응을 계속 확인합니다

내시경을 다시 고려할 단서

혈변·철결핍빈혈·야간 설사·체중 감소·위장관암 가족력, **연령에 맞는 대장암 선별검사 미시행**, 적절한 치료에도 지속·악화되는 증상은 대장내시경 등 평가의 단서입니다.

감염성 설사는 별도 접근

새 고열·혈변·염증성 설사나 C. difficile 감염이 의심되면 로페라마이드를 피합니다. **수분·전해질 보충**을 우선하며, 펩시노겐 결과로 식초·산을 보충하는 IBS 치료는 근거가 부족합니다.

새로운 증상을 기존 IBS로만 넘기지 말고 변화 시점을 알려 주세요.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 기억할 여섯 가지

생활습관 → 식단 → 약, 차례대로 함께 관리합니다

01 과민성 장 증후군은 꾀병이 아니라 **장과 뇌의 신호** 문제입니다

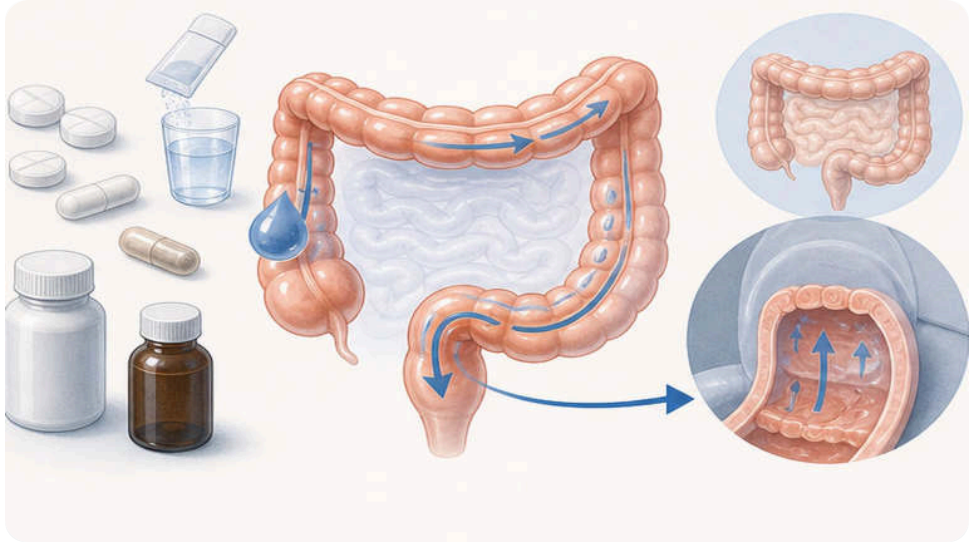
02 암이나 염증성 장질환으로 진행하지 않습니다

03 2주 동안 변 모양을 적어 **내 유형**을 알아 둡니다

04 저포드맵 식단은 **짧게** 시험하는 방법입니다

05 약은 유형과 증상에 맞춰 진료에서 고릅니다

06 피·체중 감소·가족력이 있으면 **먼저 검사**합니다



Tip · 증상 기록(언제·무엇을 먹고·변 모양)을 가져오시면 진료가 빨라집니다.

근거 · Rome IV · ACG 진료지침 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 음식 목록과 단계별 식단은 식사 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

과민성 장 증후군을 이해하고 관리하는 방법을 안내하는 설명자료입니다. 검사와 약은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

Rome IV(2016) · ACG 진료지침 2021 · Monash University 저포드맵 프로그램 · Mayer 2011 · van Rheenen 2010 · 브리스톨 대변 척도

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요